Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Assis

Rua Floriano Peixoto, 1616, Balcão Virtual (55) 99711-4261 - Bairro: Centro - CEP: 97610000 - Fone: (55) 302-99987 - 55 99711-4261 - Email: frsaofass2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001612-02.2024.8.21.0125/RS

AUTOR: DARIENE NICOLA FARIAS

RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV

SENTENÇA

Vistos e analisados os autos.

Trata-se da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Dariene Nicola Farias, em face de IPE-SAÚDE – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL. Narra a autora, na inicial, que é portadora de Leucemia Mielóide Aguda (CID- 10: C920) e que está sendo encaminhada para a realização do procedimento de transplante de medula óssea, o qual foi autorizado judicialmente, informando que necessita do medicamento LETERMOVIR, pelo prazo de 100 (cem) dias, após a realização da cirurgia, conforme recomendação médica. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Deferida a justiça gratuita, bem como concedida a tutela de urgência, determinando que o demandado forneça à autora o medicamento LETERMOVIR pelo prazo de 100 dias pós-transplante de medula óssea - evento 18, DESPADEC1.

Sobreveio a contestação do demandado, discorrendo sobre o sistema do IPE Saúde, bem como a relação entre autarquia e os servidores públicos segurados não poder ser compreendida como relação de consumo. Referiu acerca da sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde-FAS.

Aduziu sobre o pedido administrativo e que o medicamento não está previsto na cobertura, bem como a procedência deste tipo de ação não é garantia de um direito individual, mas a gradual dilapidação dos recursos do FAS - evento 34, CONT1.

Houve réplica - evento 39, RÉPLICA1.

Houve saneamento do processo, com a retificação do polo passivo para constar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPE Saúde, em lugar do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - evento 42, DESPADEC1.

As partes postularam pelo julgamento antecipado do feito.

O Ministério Público declinou de intervir no feito.

Sem mais, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Relatei. Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, tampouco outras provas a produzir.

Dito isto, é possível que se passe, diretamente, ao julgamento antecipado do mérito do pedido, na forma do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que o caso dispensa a produção de outras provas além das já contidas nos autos.

O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, caput, da Constituição de 1988, com aplicação imediata, se tratando de um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88).

No mesmo sentido, o texto constitucional do Estado do Rio Grande do Sul prevê que:

> Art. 41-A. O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)
>
> Parágrafo único. O órgão ou a entidade de que trata o “caput” poderá, mediante a devida contrapartida, baseada em cálculo atuarial que assegure o equilíbrio financeiro, verificado anualmente mediante revisão dos termos contratuais, firmar contrato para a prestação de cobertura assistencial à saúde, na forma da lei, aos servidores, empregados ou filiados, e seus dependentes, das: (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)
>
> I - entidades ou dos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta da União, do Estado e dos municípios; e (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)
>
> II - entidades de registro e fiscalização profissional, inclusive as de natureza autárquica “sui generis”. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20)

Conforme assentado pelo requerido, o plano de saúde IPE-Saúde, de fato, é instituído pela Lei Complementar n.º 15.145/18, que reorganizou o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, sendo administrado por uma Autarquia Estadual, a qual obedece aos parâmetros expostos pela referida legislação para a concessão de coberturas.

O artigo 4º da referida Lei Complementar, que revogou a Lei n.º 12.134/04, dispõe que:

> Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.
>
> § 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.
>
> § 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.
>
> § 3º Para aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde, mediante prévio estudo técnico e atuarial, o Instituto poderá instituir Planos Especiais, para disponibilizar outros serviços ou procedimentos, cuja participação é opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuserem o regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto.

Nesse contexto, o IPE Saúde alega que o medicamento LETERMOVIR não está previsto em suas tabelas de cobertura, o que, em tese, justificaria a negativa de fornecimento.

Nesses termos, com base no parágrafo 1º, em tese, ficariam excluídos da cobertura do IPE-Saúde todos os tratamentos, exames, insumos, entre outros, que não estivessem previstos na tabela feita pelo próprio instituto.

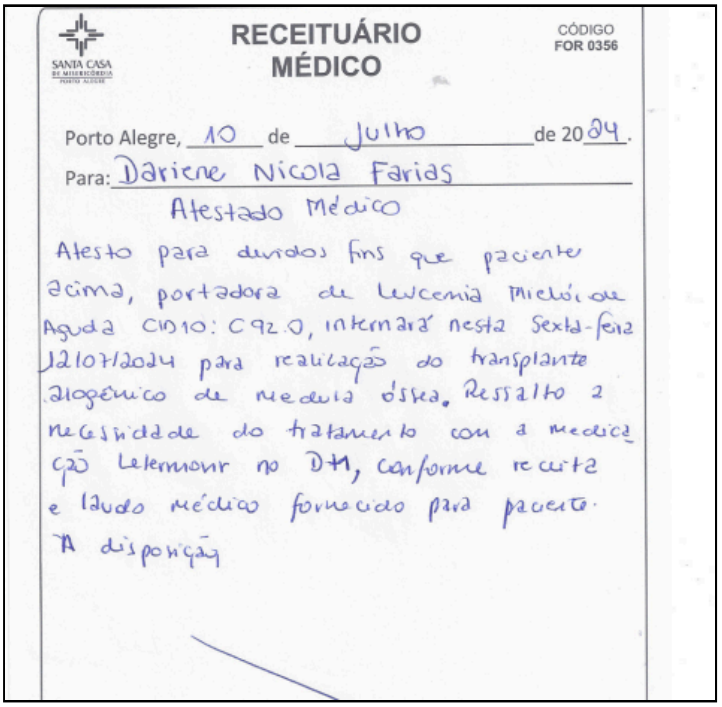
De todo modo, em que pese as disposições da nova lei, entendo que a ausência de previsão nas tabelas não deve servir como obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado.

Destaco que o médico da parte autora, por acompanhar a paciente desde o início de seu diagnóstico, é quem - ao menos em tese - tem as melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, não podendo o direito constitucional à saúde ser limitado a uma simples tabela ou protocolo.

É importante também lembrar que a limitação do critério médico na escolha do procedimento mais adequado ao seu paciente é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931/09, Anexo, Capítulo I, XVI), conforme se segue:

> "Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, **limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.**"

Da mesma forma, a necessidade da medida está na prescrição médica específica do medicamento LETERMOVIR, conforme atestado médico juntado aos autos, que indica a necessidade do uso do medicamento por 100 dias após o transplante de medula óssea, devido ao alto risco de reativação do Citomegalovírus (CMV), uma vez que tanto a autora quanto o doador apresentam sorologia positiva para este vírus.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PORTO ALEGRE

RECEITUÁRIO MÉDICO

CÓDIGO FOR 0356

Porto Alegre, 10 de Julho de 2024.

Para: Darlene Nicola Farias

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que paciente acima, portadora de Leucemia Mielóide Aguda CID10: C92.0, internará nesta Sexta-feira 12/07/2024 para realização do transplante alogênico de medula óssea. Ressalto a necessidade do tratamento com a medicação Letermovir no D+1, conforme receita e laudo médico fornecido para paciente.

A disposição

Atestado Médico

LAUDO MÉDICO
A paciente Dariene Nicola Farias tem diagnóstico de leucemia mieloide aguda com doença residual mínima positiva e indicação de transplante de células hematopoiéticas haploidêntico, pois não tem doador 100 % compatível. O transplante está previsto para junho de 2024.
A receptora e o doador apresentam sorologia positiva para CMV (Citomegalovírus). Sabidamente o
transplante em questão tem alto risco de reativação por CMV e, associado à soropositividade do receptor, este risco se torna ainda mais evidente e elevado. Assim, a paciente tem indicação do uso de profilaxia com Letermovir - 240 mg 2 x por dia - iniciando no primeiro dia após a infusão e até 100 dias após a infusão das células.
Conforme RN N° 654/2021-anexo II, a DUT 54.2 indica profilaxia (primária ou secundária) para antivirais, quando as infecções estão relacionadas ao uso de medicamentos antineoplásicos.
Referências:
1-Maiolino MG, Carlesse F e Ramos JF. Prevention and treatment of infectious complications post HSCT. J Bone Marrow Transplant Cell Ther. 2021;4(1):197-217. Disponível em: https://www.jbmtct.com.br/seer/index.php/jbmtct/article/view/82.
2-Ljungman P, Camara R, Robin C et al. Guidelines for the management of cytomegalovirus infection in patients with haematological malignancies and after stem cell transplantation from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). Lancet Infect Dis. 2019;19(8):e260-72.
3-Hakki M, Aitken SL, Danziger-Isakov L et al. American Society for Transplantation and Cellular Therapy Series: #3—Prevention of Cytomegalovirus Infection and Disease After Hematopoietic Cell Transplantation. Transpl Cell Ther. 2021:27:707-719.
28 de Agosto de 2

14 de Junho de 2024

Nesse sentido, ficando comprovada a urgência e necessidade do procedimento, incumbe ao requerido fornecê-lo.

Lembro, por fim, ser entendimento da Corte do Estado do Rio Grande do Sul e da Corte Superior STJ, que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado. Veja-se, a título de exemplo, o seguinte aresto, *verbis:*

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA INTERNA. MENOR IMPÚBERE. ENQUADRAMENTO CORRETO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. - (...) O recurso interposto em ação para prestação de cobertura de serviço de saúde a menor impúbere, não estando a pretensão amparada somente no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, também, na relação jurídica relativa ao IPE-SAÚDE, enquadra-se na subclasse Direito Previdenciário (Público). (...) (Agravo de Instrumento Nº 70080635956, Primeira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 19/02/2019) IPÊ-SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA RECURSAL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 15.145/18. MARCO TEMPORAL: DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. - O marco temporal para a aplicabilidade da Lei nº 15.145/18, que revogou a norma anterior Lei nº 12.134/04, é a data do pedido administrativo. Situação dos autos em que já aplicável a lei nova. **TERAPÊUTICA SUPOSTAMENTE NÃO PREVISTA NAS TABELAS DO INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO DISPENSADO AO SEGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. - O art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto (§1º). Ocorre que o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJRS é claro no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado.** AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081608762, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 26-06-2019) - [sem destaques no original]

Sobre a impossibilidade de negativa da autarquia sob o argumento de ausência de previsão e cobertura em casos tais, diversos são os precedentes da nossa Corte Estadual de Justiça, inclusive em casos específicos de medicamentos necessários para o sucesso de tratamentos oncológicos.

> RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEGURADO DO IPÊ-SAÚDE. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AQUISIÇÃO PARTICULAR PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REEMBOLSO. CABIMENTO. PLANO IPÊ-SAÚDE É INTEGRADO POR ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR, ATOS NECESSÁRIOS AO DIAGNOSTICO E AO TRATAMENTO, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE. EXEGESE DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 12.134/2004. PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 15.145/2018 LIMITADO ÀS PATOLOGIAS E NÃO AOS PROCEDIMENTOS. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES TERAPÊUTICAS A SEREM DEFINIDAS POR CRITÉRIO MÉDICO PRECEDENTES. COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 52425446620238210001, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 21-11-2024)

> JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS PELO DEMANDANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DEFERIDO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À TERAPIA *PSICOPEDAGÓGICA*. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO. VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM PEDAGOGO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COPARTICIPAÇÃO NOS TRATAMENTOS POSTULADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO ATACADA. I - Sabe-se que integram o Plano IPE-Saúde os atendimentos médicos, hospitalares, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/18. Embora o parágrafo primeiro, do referido artigo, cite estarem excluídos da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos,

insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto, julgo que a circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. II - Estando o(a) profissional habilitado(a) à realizar atendimento *psicopedagógico*, não se mostra razoável exigir que a prestação se dê apenas por Psicólogo(a), vedando que o tratamento seja executado por Pedagogo(a). III - Entretanto, os tratamentos multidisciplinares enquadram-se no caput do artigo 30 da Lei Estadual nº 15.145/2018, pois se caracterizam como "serviços". Desse modo, mostra-se necessária a observância da **coparticipação**. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 52914123020238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 22-02-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. *IPÊ-SAÚDE*. ANEURISMA CEREBRAL. REALIZAÇÃO DE *CIRURGIA* COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO COBERTO PELO PLANO. *NEGATIVA* DE *FORNECIMENTO*. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. A LEI ESTADUAL Nº 12.134/2004, QUE REESTRUTUROU O IPERGS, DISPÕE QUE O SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À *SAÚDE* DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS, ENGLOBA UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS, À PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA À *SAÚDE* DE SEUS USUÁRIOS (ARTS. 1º E 2º). **EM QUE PESE A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.145/2018, QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 12.066/2004, DISCIPLINANDO QUE DESCABE A IMPOSIÇÃO AO IPERGS DE *PROCEDIMENTOS*, EXAMES, TRATAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS QUE NÃO ESTEJAM PREVISTOS EM SUAS TABELAS PRÓPRIAS, APENAS JUSTIFICANDO-SE DEFINIÇÃO EM CONTRÁRIO CASO COMPROVADA A SUA INDISPENSABILIDADE, ENTENDO QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS.** INADMISSÍVEL QUE A AUTARQUIA SE RECUSE A *FORNECER* O TRATAMENTO PRETENDIDO PELA AUTORA, ESPECIALMENTE PORQUE HÁ COBERTURA PARA A ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO ÂMBITO DO *IPÊ-SAÚDE*, COM *FORNECIMENTO* DE PRÓTESES. O LAUDO MÉDICO COLACIONADO AO FEITO É EXPRESSO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE *CIRURGIA* COM COLOCAÇÃO DE STENT DIVERSOR DE FLUXO, DEVIDO ÀS ESPECIFICIDADES DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. A UNIÃO, OS ESTADOS, OS MUNICÍPIOS, OS TERRITÓRIOS FEDERAIS, O DISTRITO FEDERAL E AS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES SÃO ISENTAS DO PAGAMENTO DE TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 5º, I, DA LEI N. 14.634/2014. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER REDUZIDOS, ATENDIDAS AS CONDICIONANTES DO ART. 85, §§ 2º E 8º, CPC, PRINCIPALMENTE A QUALIDADE DO ENTE SUCUMBENTE, A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, ASSIM COMO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. *APELAÇÃO* PARCIALMENTE PROVIDA.(*Apelação* Cível, Nº 50033104220208210009, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 03-11-2021) - [sem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. *IPE-SAÚDE*. *FORNECIMENTO* DE *PROCEDIMENTO CIRÚRGICO*. *NEGATIVA* DE DISPENSA PELO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. O ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 12.134/04 DISPÕE QUE “INTEGRAM O PLANO DE *SAÚDE* ATENDIMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ATOS NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO, ASSIM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DOENÇA E PROMOÇÃO À *SAÚDE*”. **PORTANTO, NÃO É FACULTADO AO PLANO DE *SAÚDE* NEGAR O *FORNECIMENTO* DE DETERMINADO TRATAMENTO AO SEGURADO, SOB A JUSTIFICATIVA DESTE NÃO FAZER PARTE DA COBERTURA, POIS NÃO CABE AO *IPE-SAÚDE* SELECIONAR O TRATAMENTO DISPENSADO.** A REDUÇÃO DOS **HONORÁRIOS** ADVOCATÍCIOS REVELA-SE CABÍVEL, TENDO EM VISTA A REPETITIVIDADE DA MATÉRIA E OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CASOS ANÁLOGOS, MERECENDO AMPARO A PRETENSÃO DO APELANTE QUANTO AO PONTO. *APELAÇÃO* PARCIALMENTE PROVIDA.(*Apelação* Cível, Nº 50017062620198210027, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 10-09-2021) - [sem destaques no original]

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPÊ-SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO. TERAPÊUTICA SUPOSTAMENTE NÃO PREVISTA NAS TABELAS DO INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO DISPENSADO AO SEGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. - O art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto (§1º). **Ocorre que o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJRS é claro no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado. - Situação dos autos em que a gravidade do estado de saúde da paciente foi devidamente comprovada, assim como a ineficácia dos tratamentos anterior, com a necessidade do transplante de medula óssea alogênico como único recurso disponível na tentativa de salvaguarda da sua vida.** - AJG deferida apenas em sede recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082432451, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 13-11-2019) - [sem destaques no original]

Por fim, saliento que não assiste razão ao requerido quanto à coparticipação, nos termos do art. 30, parágrafo único, da LC nº 15.145/2018:

Art. 30. O usuário do Sistema IPE Saúde realizará o pagamento de parte das despesas com consultas, exames complementares, serviços ou procedimentos, a título de coparticipação, em percentual de até 40% (quarenta por cento) do valor constante de tabelas de procedimentos adotadas do IPE Saúde, conforme estabelecido em regulamento específico.

Parágrafo único. É vedada a coparticipação dos usuários nas internações hospitalares e tratamentos ambulatoriais

No presente caso, restou amplamente demonstrado que o uso do medicamento LETERMOVIR está diretamente vinculado à internação hospitalar, durante o transplante, bem como ao acompanhamento ambulatorial especializado no período pós-transplante.

Assim, não incide coparticipação, uma vez que se trata de fornecimento atrelado a situações expressamente abrangidas pela vedação prevista no parágrafo único do art. 30 da Lei Complementar nº 15.145/2018.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ***IPE-SAÚDE. NEGATIVA* DE *COBERTURA* PARA MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO *CIRÚRGICO* JÁ AUTORIZADO PELO PLANO. IMPOSSIBILIDADE.** PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. HIPÓTESE DE **COPARTICIPAÇÃO** DO USUÁRIO AFASTADA. **Em que pese o art. 4º da Lei Complementar n. 15.145/18 disponha que integram o plano de *saúde* atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, "exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto", releva-se que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cristalino quanto à impossibilidade de o plano de *saúde* eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Precedentes. Inarredável, no caso em tela, que o fato de a *cirurgia* prescrita pelo médico da parte autora exigir a utilização de material (enxerto orgânico) não contemplado expressamente pela *cobertura* do *IPE-Saúde* não afasta a obrigação do plano de fornecê-lo, haja vista a prevalência do direito constitucional à *saúde* sobre limitações administrativas.** Assim, deve o *agravado* arcar com o custeio do material postulado pelo requerente, e sem **coparticipação**. Com efeito, tem incidência a exceção do art. 30, parágrafo único, da Lei Complementar nº 15.145/2018, eis que se trata de *cirurgia* a ser realizada em ambiente hospitalar, afastando a possibilidade de **coparticipação**. Em outras palavras, uma vez internado o paciente - e para realização de delicada *cirurgia* - nada se há de diferenciar no que diz com os materiais empregados ao procedimento. Em suma, se o segurado realiza procedimentos fora do hospital, há **coparticipação**; todavia, para tudo o que fizer em ambiente hospitalar (internação ou ambulatorial), obviamente incluindo materiais, inexiste a colaboração financeira. Reforma da decisão *agravada*. DERAM PROVIMENTO AO *AGRAVO* DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (*Agravo* de Instrumento, Nº 51566614320228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 21-11-2022) *[Grifei]*.

Assim, tenho que a gravidade do quadro clínico da requerente e a urgência no fornecimento do medicamento foram comprovados desde a peça inicial, com a juntada aos autos de atestados médicos indicando a necessidade da paciente de utilizar o medicamento LETERMOVIR por 100 dias após o transplante de medula óssea.

Destaco ainda que, conforme informação constante no evento 24, OFIC1, o IPE Saúde já autorizou o fornecimento do medicamento LETERMOVIR, conforme prescrição médica.

Portanto, neste momento, cabe apenas confirmar a liminar já deferida no processo e julgar procedente o pedido para garantir à autora o direito ao medicamento necessário para o sucesso do seu tratamento de saúde.

Isso posto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos por DARIENE NICOLA FARIAS em face do IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ao efeito de confirmar a tutela de urgência concedida, obrigando o requerido a autorizar e custear o fornecimento do medicamento LETERMOVIR, conforme prescrição médica.

Isento o IPE-SAÚDE ao pagamento de custas processuais, em razão da incidência da Lei Estadual n.º 14.634/14.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte adversa, os quais arbitro em R$ 1.500,00, consoante os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 15 dias. Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, ficando as partes intimadas.

Transitada em julgado, e nada mais sendo postulado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR REVEILLEAU DOS REIS, Juiz de Direito**, em 02/09/2025, às 19:33:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084864749v37** e o código CRC **03a830b1**.